

Relatório De Polissonografia De Noite Inteira

Dados do paciente:			Data: 17/10/2025
Nome:	Ana Maria Vila Nova Aguiar	Equipamento:	APNEALINK
Médico Interpretador: Dra. DENISE L. ALVARENGA CRM: 98997			

Detalhes do dispositivo e do sensor

O estudo foi registrado de forma domiciliar em um dispositivo Apneia Link usando 1 cinta de esforço, um sensor de fluxo respiratório baseado em pressão e um oxímetro. A frequência cardíaca é obtida a partir do sensor de oxímetro.

O exame foi iniciado às 00:40 horas e finalizado às 06:28 com duração de 5 h:48 min

O número total de eventos respiratórios foi de **84**, sendo **15** apneias, **69** hipopneias. O **índice de apneias/hipopneias** (IAH) foi de **15.1** (nº/h), sendo **2.2** apneias obstrutivas, **0.4** apneias centrais, **0.2** apneias mistas e **12.4** hipopneias/h.

A permanência das posições registradas do paciente durante o tempo total de registro foram: Supina **97.0** %, não supina **43.0%** e em pé **0%**. Eventos respiratórios predominante na posição supina.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 97 %, a **média** 91 % e a **mínima** de 73 %. O **Índice de Dessaturação** foi de **19.2** e permaneceu **20** % do período analisado com SpO₂ abaixo ou igual a **90** %.

A frequência cardíaca durante o registro de PSG variou de **61 (BPM)** a **87 (BPM)**, com média de **71 (BPM)**.

Não apresentou respiração de Cheyne-Stokes.

IAH (Índice de Apneia e Hipopneia) = Apneias + Hipopneias

Conclusão:

1. Índice de apneia/hipopneia está moderadamente elevado (IAH = 15,1 eventos/hora), com predomínio de hipopneias, associadas com a queda da oxihemoglobina em sua maioria na posição supina.
2. Dessaturação da oxihemoglobina durante o exame, com SpO₂ média de 91%, permanecendo 20% do período analisado abaixo de 90%.
3. Apresentou Ronco registrado durante o exame.
4. Frequência Cardíaca média durante o tempo de registro dentro da normalidade.
5. Exame apresentou índice de apneia/hipopneia considerado moderadamente elevado durante esta noite,
6. A hipótese de Síndrome da Apneia obstrutiva do sono deve ser avaliada com a associação clínica do paciente.

DENISE
LANZONI DE
ALVARENGA:
20990180816

Assinado de forma digital por DENISE LANZONI DE ALVARENGA:20990180816
Dados: 2025.11.04 16:46:04 -03'00'

Dra. Denise L. Alvarenga
CRM 98997
Otorrinolaringologista e Médica do Sono

Relatório de diagnóstico

Detalhes da gravação				17/10/2025
Dispositivo	ApneaLink Air			Tipo: III
Gravação	Início: 12:40am	Fim: 6:28am	Duração - h:	5:48
Tempo monitor. (fluxo)	Início: 12:50am	Fim: 6:26am	Duração - h:	5:34
Avaliação saturação O2	Início: 12:50am	Fim: 6:28am	Duração - h:	5:38

Estatísticas			
			
Índice de eventos	IER (IAH):	15.1	IA: 2.7 IH: 12.4
Supina	Tempo - h	5:24	Porcentagem: 97.0
	IER (IAH):	15.2	IA: 2.6 IH: 12.6
Não-supina	Tempo - h	0:09	Porcentagem: 3.0
	IER (IAH):	12.1	IA: 6.0 IH: 6.0
Em pé	Tempo - h	0:00	Porcentagem: 0.0
	IER (IAH):	0.0	IA: 0.0 IH: 0.0
Eventos totais	Apneias:	15	Hipopneias: 69
AI	Obstrutiva: 2.2 Central: 0.4	Mista: 0.2	Não classificado: 0.0
Resp. Cheyne-Stokes	Tempo - h:	0:00	Porcentagem: 0
Dessaturação de oxigênio	IDO:	19.2	Total: 108
% Saturação de oxigênio	Valor inicial:	97	Média: 91 Mais baixo: 73
Satur. O2 - %tempo aval.	Set. <=90%: 20	Set. <=85%: 4	Set. <=80%: 1
	Set. <=88%: 7	Tempo<=88%-h:	0:22
Respirações	Total:	5103	Média/minuto: 15.3 Ronco: 562
Pulso - bpm	Mín.:	61	Média: 71 Máx.: 87

Orient. análises: **AASM 2012, Classificação manual**

Apneia[10%; 10 s; 80 s; 1,0 s; 20%; 60%; 8%]; Hipopneia[70%; 10 s; 100 s; 1,0 s]; Ronco[6,0%; 0,3 s, 3,5 s; 0,5 s]; Dessaturação [3,0%]; RCS[0,5]. Sensor Airflow e sensor de esforço respiratório: transdutor de pressão. As hipopneias foram classificadas apenas se tiver havido dados de oximetria válidos.

Gráficos



10 DICAS PARA UM SONO DE QUALIDADE

- 1 – Estabeleça um horário regular para dormir e acordar;
- 2 – Se você tem o hábito de cochilar após o almoço, não exceda 45 minutos;
- 3 – Evite ingerir bebidas alcoólicas 4 horas antes do horário de dormir e também não fume nesse período;
- 4 – Evite ingerir bebidas com cafeína (café, chá preto, refrigerantes de cola, chocolate) nas 6 horas antes do horário de dormir;
- 5- Evite refeições pesadas, excessivamente picantes ou adocicadas 4 horas antes do horário de dormir;
- 6 – Faça exercícios físicos regularmente (mas não próximo do horário de dormir) e se possível pegando o sol da manhã;
- 7- Durma em uma cama confortável para você, e evite levar trabalho ou fazer refeições nela. A cama deve ser limpa e com cobertas adequadas a temperatura ambiente;
- 8 – Encontre uma temperatura ambiente confortável para o sono e mantenha o quarto bem ventilado;
- 9 – Elimine todos os ruídos do quarto e mantenha o quarto mais escuro possível;
- 10 – Evite equipamentos eletrônicos (computador, telefone celular, televisão) uma hora antes do seu horário de dormir;

DORMIR BEM, FAZ BEM – VALORIZE O SEU SONO